PROCESO[1]

ASISTENCIA A URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR SUAP/UME GESTIONADA POR CCU

Fecha de elaboración	Versión	Fecha prevista de revisión
AGOSTO 2019	1.0	AGOSTO 2021

MISIÓN[2]

El proceso "Asistencia a urgencias y emergencias por SUAP/UME gestionada por CCU" atiende las necesidades de los usuarios que demandan atención sanitaria de urgencias o emergencias y en la que el CCU asigna recurso (SUAP o UME) para la asistencia en el lugar de la demanda.

Enfoque	Punto de vista
General	Organizacional

ALCANCE[3]

Límite de Entrada	Límite de Salida
▪ Aviso gestionado desde el CCU que requiere de una asistencia de urgencias o emergencias en el lugar de la demanda. ▪ Aviso de auto-activación ratificado desde CCU que requiere de una asistencia de urgencias o emergencias en el lugar de la demanda.	▪ Alta en el lugar o derivación del usuario al destino que su situación requiera tras el fin de la actuación de los profesionales de urgencias/emergencias.

CLIENTES[4]

1. Usuario de la asistencia.	
Necesidades y expectativas	▪ Asistencia sanitaria de urgencias o emergencias ▪ Seguridad en la actuación ▪ Efectividad en la resolución ▪ Atención personalizada ▪ Información adecuada ▪ Toma de decisiones consensuada ▪ Intercomunicación entre los niveles asistenciales y continuidad en la atención
2. Acompañantes del usuario (familia, amigos,…)	
Necesidades y expectativas	▪ Efectividad en la resolución del proceso ▪ Información sobre la situación
3. Otros profesionales de la organización (Atención Primaria, FEA Urgencias de puerta de hospital,…)	
Necesidades y expectativas	▪ Asistencia sanitaria adecuada ▪ Trazabilidad del paciente ▪ Continuidad de cuidados
4. Servicio Murciano de Salud	

CELDRAN GIL, FRANCISCO 03/09/2019 14:25:10
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-f818 7b37-ee45-a813-1227-005056 9b6280

Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia
C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ªPlanta
30005 Murcia

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001
AENOR Transporte Sanitario UNE 179002

Puesto y firma:

Director Gerente 061
D.Francisco Celdrán Gil

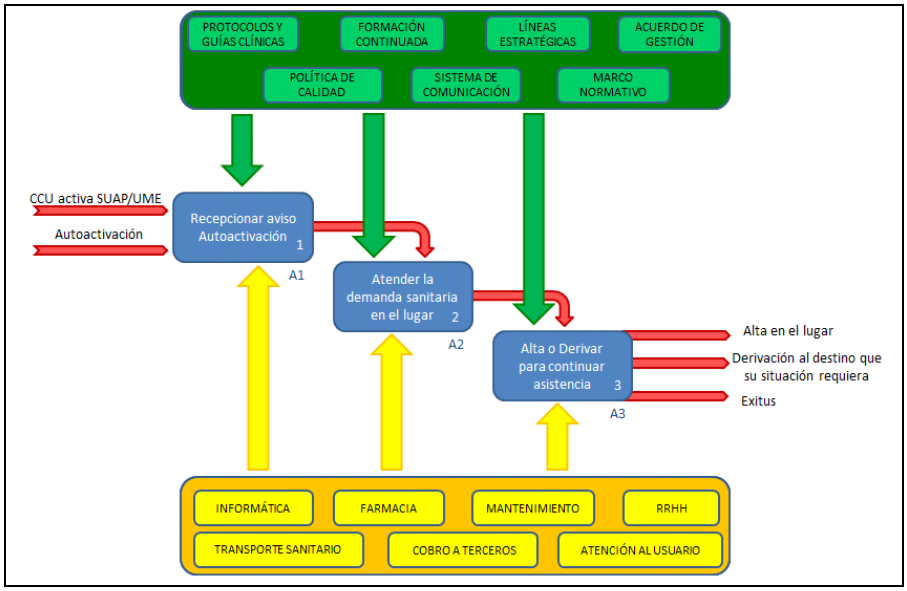
(Documento firmado electrónicamente al margen)

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en http://10.181.8.6/intranet/

Necesidades y expectativas	▪ Cumplimiento del Contrato de Gestión ▪ Seguimiento de los proyectos estratégicos

DIAGRAMA DE CONTEXTO (A-0). ASISTENCIA A URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR SUAP/UME GESTIONADA POR CCU

DIAGRAMA A0. ASISTENCIA A URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR SUAP/UME GESTIONADA POR CCU



CELDRAN GIL, FRANCISCO 03/09/2019 14:25:10
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-f818b7b37-ee45-a813-1227-005056 9b6280

ARBOL NODAL[5]

0. ASISTENCIA A URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR SUAP/UME GESTIONADA POR CCU
A1.Recepcionar aviso. Auto-activación
  A11.Mantener la operatividad de la ambulancia de SVA
    A111. Vehículo y equipación
    A112. Limpieza
    A113. Material sanitario y farmacológico
  A12. Activar la unidad (SUAP/UME)
    A121. CCU
    A122. Auto-activación
  A13. Aproximación al lugar de la asistencia
  A14. Llegada al lugar de la asistencia
    A141.Comunicar llegada a CCU y registrar hora de llegada en Historia Clínica
    A142. Valoración del entorno
    A143. Asegurar la zona
    A144. Examinar la pertinencia de la cumplimentación de documentación extra (cobro a terceros, parte al juzgado, sospecha de violencia de género o maltrato infantil)
A2. Atender la demanda sanitaria en el lugar
  A21. Asistencia en caso de emergencia
    A211. Estabilización
    A212. Reevaluar la situación para solicitar nuevos recursos al CCU
    A213. Anamnesis y exploración física
    A214. Pruebas complementarias
    A215. Diagnóstico o aproximación diagnóstica
    A216. Tratamiento y cuidados de enfermería
  A22. Asistencia en caso de urgencia
    A221. Anamnesis y exploración física
    A222. Pruebas complementarias
    A223. Diagnóstico o aproximación diagnóstica
    A224. Tratamiento y cuidados de enfermería
A3. Alta o derivar para continuar asistencia
  A31. Alta en el lugar
  A32. Derivación al destino que su situación requiera
    A321.Centro útil
    A322. Hospital de referencia
    A323. Otros
  A33. Exitus
  A34. Retorno a estado operativo

CELDRAN GIL, FRANCISCO 03/09/2019 14:25:10
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-f818 7b37-ee45-a813-1227-0050569b6280

CELDRAN GIL, FRANCISCO 03/09/2019 14:25:10

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-f818 7b37-ee45-a813-1227-0050569b6280

PROCEDIMIENTOS[6]

0. Garantizar la operatividad de la ambulancia de SVA.

La ambulancia de SVA (SUAP y UME) debe estar operativa y en condiciones suficientes para ser activada por el CCU, esto tendrá lugar en aquellos casos en los que se requiera de una asistencia de urgencias o emergencias in situ. El médico de SUAP y UME es el responsable de garantizar la operatividad del vehículo y su equipación, la limpieza del mismo y la dotación adecuada de material sanitario y farmacológico.

1. Activar la ambulancia de SVA (SUAP/UME).

La activación de la ambulancia de SVA puede hacerse de dos modos distintos: a través de CCU y por auto-activación.

El primero de los casos, proviene como resultado del proceso clave “gestionar la asistencia sanitaria a través de CCU”. En este caso el CCU recibe una carta de llamada (PA) desde el 112, la gestiona y, en el caso pertinente, asigna el recurso SUAP/UME para la asistencia en el lugar de la demanda. Desde el CCU y bajo la responsabilidad del médico regulador, se activa el recurso oportuno (SUAP/UME) a través de una llamada telefónica. El técnico cumplimenta los datos administrativos en la historia clínica (nº de aviso, fecha y hora de la llamada, lugar de la asistencia, motivo de consulta y datos de identificación del usuario).

Por último, la ambulancia de SVA puede auto-activarse bajo la responsabilidad del médico de SUAP/UME, quien identifica una situación como susceptible de activación (por ejemplo, una persona que acude al SUAP y describe una situación de urgencia, o la solicitud de asistencia sanitaria de cualquier viandante al ver la ambulancia de SVA) y se comunica con el médico regulador de CCU para que quede legitimada tal activación.

La activación de la ambulancia de SVA debe de realizarse en el menor tiempo posible, para lo cual todos los miembros del equipo son responsables colectiva e individualmente.

2. Aproximación al lugar de la asistencia.

Es el proceso que comprende desde el inicio del desplazamiento hasta la llegada al lugar de la intervención. El técnico es responsable de realizar la aproximación en consonancia con las características del aviso y con la tipología de la vía.

Se pone especial cuidado en evitar molestias innecesarias a los ciudadanos y sobre todo en las zonas cercanas al centro del SUAP/UME y a los hospitales de derivación.

El médico de SUAP/UME coordina la aproximación al lugar de la intervención y es responsable de comunicar al CCU cualquier tipo de incidencia que pueda afectar negativamente al tiempo previsto para la aproximación.

3. Llegada al lugar de la asistencia.

A la llegada al lugar de la asistencia, el técnico registra en la historia clínica la

hora exacta de llegada y se establece una comunicación con el CCU para informar del nuevo estado.

El médico de SUAP/UME es el responsable de realizar una valoración previa del entorno en el que el equipo ha de operar, solicitando al CCU si así lo considera necesario, la intervención de otros dispositivos asistenciales o no asistenciales (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).

El médico de SUAP/UME es el responsable de asegurar la zona para permitir la intervención del equipo dentro de los máximos niveles de seguridad posible.

En general, cuando en el lugar del incidente confluyan varios servicios de atención a emergencias (bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc…), el médico de SUAP/UME utilizará su más amplio criterio para coordinar la actuación de su equipo con la de los profesionales del resto de los servicios de atención, poniendo en conocimiento del CCU las incidencias que pudieran producirse.

Una vez garantizado un entorno seguro de trabajo, si la situación lo permite y la información es suficiente, se examina si la demanda sanitaria de urgencias y emergencias solicitada es compatible con la cumplimentación de alguna documentación extra (cobro a terceros, parte al juzgado, sospecha de violencia de género o maltrato infantil).

4. Atender la demanda sanitaria en el lugar.

En caso de emergencia, la primera actuación va encaminada a la estabilización inicial del usuario, y una vez realizada se revalúa la situación para solicitar los recursos necesarios a través de una llamada telefónica directa al CCU. A continuación se procedería, en la medida de lo posible, con una asistencia estandarizada con anamnesis, exploración física, pruebas complementarias, diagnóstico o aproximación diagnóstica, tratamiento y cuidados de enfermería.

En caso de urgencia, el médico procede con la anamnesis y exploración física, la enfermera se encarga de las pruebas complementarias, el médico propone un diagnóstico o aproximación diagnóstica para, finalmente establecer un tratamiento y cuidados de enfermería.

5. Alta o derivar para continuar asistencia.

Una vez se ha implementado la asistencia sanitaria, el usuario tiene diferentes salidas del sistema en función de su situación y necesidad: alta, derivación al destino que su situación requiera o exitus.

En el caso de alta en el lugar, se informa al usuario de la asistencia prestada, se le da una copia de su Historia Clínica y se le remite a control por su médico de familia, enfermera de zona u otros (mutua o compañía de seguro privada).

En el caso de derivación al destino que su situación requiera, esta puede ser a un centro útil (por ejemplo, derivar a HUVA en caso de TCE, por ser el único centro en la Región de Murcia con servicio de Neurocirugía), al hospital de referencia o a otros (tipo centro de salud o SUAP). En cualquiera de los casos de derivación se debe hacer la transferencia adecuada del usuario al centro destino, de médico a

CELDRAN GIL, FRANCISCO 03/09/2019 14:25:10
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-f818 7b37-ee45-a813-1227-0050569b6280

médico y de enfermera a enfermera y acompañado siempre de la copia de su historia clínica. En ciertos casos, el usuario es derivado al hospital de referencia a través de una ambulancia no asistencial (ANA), en ese caso, el médico de SUAP/UME se comunica con CCU y solicita transporte sanitario tipo ANA, dejando una copia de su historia clínica al usuario e informándolo de la situación.

En el caso de exitus, existen 2 itinerarios posibles: cuando la muerte del usuario se produce por causas que el médico de SUAP/UME valora como naturales, este cumplimenta el certificado de defunción correspondiente, por otro lado, si de la valoración se obtienen indicios fundados de muerte violenta o no natural, se solicita la intervención del forense de guardia a través de las fuerzas de seguridad competentes o del CCU.

En todos los casos, al finalizar la intervención sanitaria, el médico de SUAP/UME es responsable de comunicar este hecho al CCU para que este proceda al cierre de la carta de llamada.

6. Retorno al estado operativo.

Una vez finalizada la intervención y notificada al CCU el cierre de la misma, se procede a la reactivación del estado operativo de la ambulancia de SVA. En algunos casos se procederá de forma inmediata (en aquellos en los que la asistencia realizada no precisa de limpieza del habitáculo o reposición urgente de material sanitario/farmacológico), en otros, sin embargo, será necesario la restitución de equipación, limpieza de la ambulancia, y reposición de material sanitario/farmacológico y en ese caso se notificará al CCU de la necesidad de la misma, así como también, se notificará el momento en que la unidad queda operativa.

OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL PROCESO[7]

1. Gestionar la asistencia de urgencias y emergencias a través de la movilización de SUAP o UME por el CCU
2. Establecer el proceso asistencial "Asistencia a urgencias y emergencias por SUAP/UME gestionada por CCU"
3. Incorporar dicho documento al Plan de Gestión de la Dirección de la Gerencia 061 para difundirlo entre sus profesionales
4. Gestionar eficientemente los recursos en el proceso de urgencias extrahospitalarias
5. Mejorar la satisfacción de usuarios y profesionales

INDICADORES[8]

Grupo[9] 1. Indicadores de actividad.	
Código	Nombre del indicador
1.01.	Número de movilizaciones por SUAP
1.02.	Número de movilizaciones de enfermería por SUAP
1.03.	Número de movilizaciones por UME

CELDRAN GIL, FRANCISCO 03/09/2019 14:25:10
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-f818 7b37-ee45-a813-1227-0050569b6280

1.04.	Número de traslados interhospitalarios por UME
1.05.	Número de activaciones código ictus por SUAP
1.06.	Número de activaciones código ictus por UME
1.07.	Número de accidentes de tráfico atendidos por SUAP
1.08.	Número de accidentes de tráfico atendidos por UME
Grupo 2.Accesibilidad.	
Código	Nombre del indicador
2.01.	Tiempo invertido desde la activación a la llegada al lugar de la unidad para prioridad A1
2.02.	Tiempo invertido desde la activación a la llegada al lugar de la unidad para prioridad A2
2.03.	Media de tiempo invertido en la resolución de las asistencias
Grupo 3.Seguridad.	
Código	Nombre del indicador
3.01.	Nivel de calidad percibida por el usuario (encuesta de calidad)
3.02.	Registro de la revisión diaria de la ambulancia
3.03.	Registro del control de temperatura de la nevera de la ambulancia
3.04.	Registro del control de estupefacientes
3.05.	Tasa de eventos adversos notificador por UME en SINASP
3.06.	Registro del conjunto mínimo de datos en la historia clínica SUAP/UME
Grupo 4. Calidad científico-técnica.	
Código	Nombre del indicador
4.01.	Adecuación al protocolo: Manejo avanzado de la vía aérea en UME
4.02.	Adecuación al protocolo: Resucitación cardiopulmonar en UME
4.03.	Adecuación al protocolo: Crisis convulsivas en el adulto en UME
4.04.	Adecuación al protocolo: Atención al gran quemado en UME
4.05.	Adecuación al protocolo: Anafilaxia en UME
4.06.	Adecuación al protocolo: Atención a la Insuficiencia cardíaca en UME
4.07.	Adecuación al protocolo: Atención al Síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST)
4.08.	Adecuación al protocolo: Atención al Ictus en UME
4.09.	Derivación al hospital en SSCC por UME
4.10.	Derivación a hospital en SSCC por SUAP
4.11.	Tasa de fallecimientos durante la asistencia
4.12.	Cumplimentación adecuada del registro de PCR en aplicativo OHSCAR
Grupo 5.Satisfacción.	
Código	Nombre del indicador
5.01.	Satisfacción en el Área de Urgencias Extrahospitalarias 061 (encuesta de satisfacción usuarios)
5.02.	Accesibilidad en el Área de Urgencias Extrahospitalarias 061 (encuesta de satisfacción usuarios)
5.03.	Nivel de calidad percibido por el profesional (encuesta de satisfacción al profesional)

CELDRAN GIL, FRANCISCO 03/09/2019 14:25:10
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-f818 7b37-ce45-a813-1227-0050569b6280

Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia
C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ªPlanta
30005 Murcia

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001
AENOR Transporte Sanitario UNE 179002

Puesto y firma:

Director Gerente 061
D.Francisco Celdrán Gil

(Documento firmado electrónicamente al margen)

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en http://10.181.8.6/intranet/

5.04.	Número de reclamaciones por SUAP/UME
5.05.	Número de reclamaciones por motivo
5.06.	Número de agradecimientos por SUAP/UME

[1] Nombre del proceso. Utilizar un formulario para cada proceso.
[2] Función o tarea básica que desempeña el proceso
[3] Delimitar la extensión del proceso explicitando sus competencias, desde dónde hasta dónde va a actuar
[4] Persona o conjunto de personas que reciben y valoran lo que les llega desde el proceso, explicitando sus necesidades (lo que es necesario para resolver/gestionar el problema) y expectativas (lo que esperan que les suceda/exista)
[5] Detallar (desde lo más global hasta lo más concreto) qué tiene que hacer el proceso para conseguir su misión.
[6] Detallar cómo se harán las cosas que previamente se ha acordado que el proceso debe hacer.
[7] Listar qué queremos conseguir con la puesta en marcha de este proceso, no cuantificar estas metas.
[8] Aspecto relevante que resume en la medida lo posible un aspecto del proceso que deseamos monitorizar, utilizado no para medir sino sobre todo como herramienta para comprobar su conformidad con un valor estándar.
[9] Categoría que agrupa a varios indicadores, por lo general en relación con los objetivos de gestión del proceso

CELDRAN GIL, FRANCISCO 03/09/2019 14:25:10
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-f818 7b37-ee45-a813-1227-005056 9b6280